



6410653040

GC-SPOR



ALAB laboratoria Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30
Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Gdynia,
ul. Powstania Styczniowego 9B 81-519 Gdynia, tel. 58 699 88 59
cs.gdynia@alab.com.pl, www.alab.pl

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych

Troka Paweł

PESEL: 91021407790
Data urodzenia: 14-02-1991
Adres: nie podano
Ident. pacjenta: 193744
Płeć: mężczyzna

Zleceniodawca: ALAB Sport, Lab. Gdynia
Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca
Lekarz zlecający: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza
Data i godz. rejestracji zlecenia: 07-07-2026 07:09
Data wykonania badania: 07-07-2026

Ident. dokumentu zlecenia: AS00018392
Nr/data w księdze prac. diagn.: 5508 / 20-05-2026

Hematologia

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Krew żylna pełna (EDTA), data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:02 (Zuzanna Stelmaszuk), data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:32				
Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów				
Leukocyty (WBC)	7,0 10 ⁹ /L	4,0 — 10,0	a1 - 10:22 07-07-2026	PB 002_C55_93 wyd. 1 z dnia 28.04.2026
<u>Rozdział automatyczny leukocytów:</u>				
Neutrocyty (NEU)	2,7 10 ⁹ /L	1,9 — 7,0		
Limfocyty (LYMPH)	2,9 10 ⁹ /L	1,5 — 4,5		
Monocyty (MON)	0,7 10 ⁹ /L	0,1 — 0,9		
Eozynocyty (EOS)	↑ 0,5 10 ⁹ /L	0,05 — 0,50		
Bazocyty (BASO)	0,1 10 ⁹ /L	0,00 — 0,10		
Niedojrzałe granulocyty	0,0 10 ⁹ /L	< 0,04		
Neutrocyty (NEU%)	↓ 39,10 %	45,0 — 70,0		
Limfocyty (LYMPH%)	41,6 %	25,0 — 45,0		
Monocyty (MON%)	↑ 10,4 %	2,0 — 9,0		
Eozynocyty (EOS%)	↑ 7,7 %	0,00 — 5,00		
Bazocyty (BASO%)	0,9 %	0,0 — 1,0		
Niedojrzałe granulocyty %	0,3 %	0,0 — 0,5		
Erytrocyty (RBC)	5,3 10 ¹² /L	4,6 — 6,5		
Hemoglobina (HGB)	15,80 g/dL	13,5 — 18,0		
Hematokryt (HCT)	45,9 %	40,0 — 52,0		
<u>Wskaźniki czerwonych krwinek:</u>				
Średnia objętość erytrocyta (MCV)	86,8 fL	80,0 — 98,0		
Średnia masa HGB w erytrocytach (MCH)	29,9 pg	27,0 — 32,0		
Średnie stężenie HGB w erytrocytach (MCHC)	34,4 g/dL	31,0 — 37,0		
Wskaźnik anizocytozy erytrocytów (RDW)	13,4 %	11,5 — 14,5		
Wskaźnik anizocytozy erytrocytów (RDW)	42,0 fL	35,1 — 43,9		
Płytki krwi (PLT)	230,0 10 ⁹ /L	150,0 — 400,0		
<u>Wskaźniki płytkowe:</u>				
Płytkokryt (PCT)	0,25 %	0,12 — 0,36		
Wskaźnik anizocytozy płytek krwi (PDW)	14,1 fL	9,8 — 16,1		
Średnia objętość płytki krwi (MPV)	11,0 fL	7,0 — 12,0		
Odsetek płytek dużych	33,4 %	19,2 — 47,0		

Metoda automatyczna, analizator Sysmex XN-9100, firma Sysmex.

Badanie ogólne moczu

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Mocz, data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:02, data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:38				
Badanie ogólne moczu (A01)				
Kolor	jasnożółty		b2 - 12:13 07-07-2026	PB 005_A01_93 wyd. 1 z dnia 20.04.2026
Przejrzystość	przejrzysty			
Ciepota właściwa	1,008	1,005 — 1,030		
PH	5,5	5,0 — 8,0		
Białko	nie wykryto	nie wykryto		
Glukoza	nie wykryto	nie wykryto		
Urobilinogen	w normie	w normie		
Bilirubina	nie wykryto	nie wykryto		
Ciała ketonowe	nie wykryto	nie wykryto		
Leukocyty	nie wykryto	nie wykryto		
Azotyny	nie wykryto	nie wykryto		
Erytrocyty	nie wykryto	nie wykryto		



6410653040

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych - c.d.

Troka Paweł

PESEL: 91021407790
Data urodzenia: 14-02-1991
Adres: nie podano
Ident. pacjenta: 193744
Płeć: mężczyzna
Ident. dokumentu zlecenia: AS00018392
Nr/data w księdze prac. diagn.: 5508 / 20-05-2026

Zleceniodawca: ALAB Sport, Lab. Gdynia
Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca
Lekarz zlecający: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza
Data i godz. rejestracji zlecenia: 07-07-2026 07:09
Data wykonania badania: 07-07-2026

Badanie ogólne moczu - c.d.

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Mocz, data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:02, data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:38				
Uwagi:	Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i niewystąpieniem w badanym materiale przekroczenia ustalonych limitów - wynik nie wymaga weryfikacji mikroskopowej			

Badanie ogólne moczu wykonano metodą fotometrii odbiciowej i refraktometrii na analizatorze UC-3500 firmy Sysmex
W przypadku dodatniego wyniku białka lub glukozy zalecana jest weryfikacja analitu metodą ilościową w dobowej zbiorce moczu.

Biochemia

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Krew żylna pełna (EDTA), data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:02 (Zuzanna Stelmazuk), data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:32				
Hemoglobina glikowana (DCCT)	5,3 %	4,8 — 5,9	c3 - 12:10 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-04 v7.0 PL
Hemoglobina glikowana (IFCC)	34 mmol/mol	29 — 42		
Badanie wykonano turbidymetryczną metodą immunoinhibicyjną (TINIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.				
Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:02 (Zuzanna Stelmazuk), data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:32				
Sód w surowicy (O35)	139 mmol/l	136 — 145	d3 - 12:10 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-06 v2.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą potencjometrii pośredniej.				
Potas w surowicy (N45)	4,0 mmol/l	3,5 — 5,1	d3 - 12:10 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-06 v6.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą potencjometrii pośredniej.				
Wapń całkowity w surowicy (O77)	9,58 mg/dL	8,60 — 10,00	c3 - 13:03 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-12 v8.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.				
Magnez w surowicy (M87)	2,07 mg/dl	1,60 — 2,60	c3 - 13:03 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-01 v 8.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.				
Fosfor nieorganiczny w surowicy (L23)	3,10 mg/dl	2,50 — 4,50	c3 - 13:03 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-11 v7.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.				
Kreatynina w surowicy (M37)	0,96 mg/dl	0,70 — 1,20	c3 - 13:35 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-12 v7.0 PL
EGFR	101,5 ml/min/1,73m ²	>=90 - prawidłowe/zwiększone eGFR 60-89 - niewielkie zmniejszenie eGFR 45-59 - zmniejszenie niewielkie do umiarkowanego eGFR 30-44 - zmniejszenie umiarkowane do ciężkiego eGFR 15-29 - ciężkie zmniejszenie eGFR <15 - schyłkowa niewydolność nerek		

Wartość eGFR wyliczona wzorem CKD-EPI.
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.

Kwas moczowy w surowicy (M45)	3,8 mg/dl	3,4 — 7,0	c3 - 13:33 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-12 v9.0 PL
-------------------------------	-----------	-----------	--------------------------	--

Wartości pożądane dla osób z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym wg. stanowiska ekspertów dotyczącym hiperurykemii (Arterial Hypertens. 2017, vol.21, no 1, p.1-9): <5,0 mg/dl (<297,5 μmol/l).

W leczeniu dny moczanowej EULAR rekomenduje poziom docelowy <6mg/dl (<357 μmol/l).

Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.

Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19)	33 U/L	< 50	c3 - 13:32 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-07 v9.0 PL
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie CobasPro firmy Roche.				
Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17)	18 U/L	< 50	c3 - 13:32 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-11 v8.0 PL

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie CobasPro firmy Roche.



6410653040

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych - c.d.

Troka Paweł

PESEL: 91021407790
Data urodzenia: 14-02-1991
Adres: nie podano
Ident. pacjenta: 193744
Płeć: mężczyzna
Ident. dokumentu zlecenia: AS00018392
Nr/data w księdze prac. diagn.: 5508 / 20-05-2026

Zleceniodawca: ALAB Sport, Lab. Gdynia
Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca
Lekarz zlecający: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza
Data i godz. rejestracji zlecenia: 07-07-2026 07:09
Data wykonania badania: 07-07-2026

Biochemia - c.d.

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:02 (Zuzanna Stelmaszuk), data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:32				
Kinaza kreatynowa (CK) (M18)	↑ 222 U/L	20 — 200	c3 - 13:26 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-12 v8.0 PL

Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.

Cholesterol całkowity w surowicy (I99)	118 mg/dL	Zgodnie z zaleceniami PTDL i PTL z 2024: Wartość pożądana na czczo i nie na czczo: <190 mg/dl >300 mg/dl - wartość alarmowa	c3 - 13:26 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-12 v10.0 PL
--	-----------	--	--------------------------	---

Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.

Cholesterol HDL w surowicy (K01)	38 mg/dl	Zgodnie z zaleceniami PTDL i PTL z 2024: Wartości pożądane Na czczo i nie na czczo: Kobiety: > 45 mg/dl Mężczyźni: > 40 mg/dl	c3 - 13:24 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-01 v8.0 PL
----------------------------------	----------	--	--------------------------	--

Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.

Cholesterol LDL (wyliczany)	68 mg/dl	Zgodnie z zaleceniami PTDL i PTL z 2024 Wartości pożądane na czczo i nie na czczo: <40 mg/dl - przy ekstremalnym ryzyku sercowo-naczyniowym <55 mg/dl - przy bardzo dużym ryzyku sercowo-naczyniowym <70 mg/dl - przy dużym ryzyku sercowo-naczyniowym <100 mg/dl - przy umiarkowanym ryzyku sercowo-naczyniowym <115 mg/dl - przy małym ryzyku sercowo-naczyniowym >190 mg/dl - wartość alarmowa	c3 - 13:18 07-07-2026	
Nie-HDL	81 mg/dl	Zgodnie z zaleceniami PTDL i PTL z 2024 Wartości pożądane na czczo i nie na czczo: <70 mg/dl - przy ekstremalnym ryzyku sercowo-naczyniowym <85 mg/dl - przy bardzo dużym ryzyku sercowo-naczyniowym <100 mg/dl - przy dużym ryzyku sercowo-naczyniowym <130 mg/dl - przy umiarkowanym ryzyku sercowo-naczyniowym		

Cholesterol LDL wliczany na podstawie wzoru Sampson-NIH. Stężenie triglicerydów powyżej 800 mg/dl uniemożliwia wyliczenie cholesterolu LDL. Wskazane jest wówczas powtórzenie badania lub badanie cholesterolu LDL metoda bezpośrednią.

Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.

Triglicerydy w surowicy (O49)	57 mg/dL	Zgodnie z zaleceniami PTDL i PTL z 2024: Wartości pożądane: Na czczo: <100 mg/dl Nie na czczo: <125 mg/dl >880 mg/dl - wartość alarmowa	c3 - 13:23 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-04 v9.0 PL
-------------------------------	----------	---	--------------------------	--

Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.



6410653040

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych - c.d.

Troka Paweł

PESEL: 91021407790
Data urodzenia: 14-02-1991
Adres: nie podano
Ident. pacjenta: 193744
Płeć: mężczyzna
Ident. dokumentu zlecenia: AS00018392
Nr/data w księdze prac. diagn.: 5508 / 20-05-2026

Zleceniodawca: ALAB Sport, Lab. Gdynia
Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca
Lekarz zlecający: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza
Data i godz. rejestracji zlecenia: 07-07-2026 07:09
Data wykonania badania: 07-07-2026

Biochemia - c.d.

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:02 (Zuzanna Stelmaszuk), data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:32				
Albumina w surowicy	48,90 g/l	35,00 — 52,00	c3 - 13:38 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-07 v7.0 PL
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie CobasPro firmy Roche.				
Żelazo w surowicy (O95)	125 µg/dl	33 — 193	c3 - 13:02 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-03 v8.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.				
Transferyna	3,00 g/l	2,00 — 3,60	c3 - 13:01 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-04 v9.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.				
Białko C-reaktywne CRP-hs (wysokiej czułości) (I81)	0,611 mg/L	< 5,000	c3 - 12:17 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-05 v9.0 PL
Badanie wykonano metodą immunturbidymetryczną na aparacie CobasPro firmy Roche.				
CDC/AHA zaleca następujące wartości odcięcia dla hsCRP (tercyle) w celu oceny ryzyka choroby sercowo-naczyniowej: <1,0 mg/L niskie ryzyko 1,0-3,0 mg/L przeciętne ryzyko >3,0 mg/L wysokie ryzyko U pacjentów z wyższym stężeniem hsCRP istnieje większe prawdopodobieństwo zawału mięśnia sercowego oraz wystąpienia poważnej choroby naczyń obwodowych.				

Materiał: Mocz, data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:02 (Zuzanna Stelmaszuk), data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:38

Kreatynina w moczu (M37)	63,1 mg/dL	39,0 — 259,0	d4 - 19:50 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-12 v7.0 PL
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie CobasPro firmy Roche.				
Albumina w moczu (mikroalbuminuria)	<3 mg/l	< 20,0	d4 - 19:50 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-07 v9.0 PL
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie CobasPro firmy Roche. Uwaga: zmiana wartości referencyjnych od dnia 21.10.2024r.				
Materiał: Krew żylna, osocze (fluorek), data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:02 (Zuzanna Stelmaszuk), data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:34				
Glukoza (L43)	86 mg/dl	70 — 99	d3 - 11:11 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-01 v8.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.				

Immunochemia

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:02 (Zuzanna Stelmaszuk), data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:32				
TSH (L69)	↑ 4,57 mIU/L	0,270 — 4,200	d3 - 11:19 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2023-06 v6.0 PL
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche. UWAGA! Wartości referencyjne dla kobiet ciężarnych opracowano na podstawie Wytycznych Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wyd. 2021 r. Zmiana obowiązuje od 24.06.2026 r.				
FT3 (O55)	5,47 pmol/L	3,10 — 6,80	c3 - 13:30 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2023-07 v3.0 PL
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche. UWAGA! Wartości referencyjne dla kobiet ciężarnych opracowano na podstawie Wytycznych Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wyd. 2021 r. Zmiana obowiązuje od 24.06.2026 r.				
FT4 (O69)	19,80 pmol/L	11,90 — 21,60	c3 - 13:31 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-08 v3.0 PL
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche. UWAGA! Wartości referencyjne dla kobiet ciężarnych opracowano na podstawie Wytycznych Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wyd. 2021 r. Zmiana obowiązuje od 24.06.2026 r.				
Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)	↑ 54,7 nmol/L	18,3 — 54,1	c3 - 13:55 07-07-2026	
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA).				
Testosteron (O41)	↑ 32,10 nmol/l	8,64 — 29,00	d3 - 12:08 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-08 v4.0 PL
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.				
Kortyzol (M31)	17,4 µg/dl	godz. 6:00-10:00 4,82-19,5 godz. 16:00-20:00 2,47-11,9	c3 - 13:50 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-12 v6.0 PL
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.				
Insulina (L97)	8,6 µU/mL	2,6 — 24,9	d3 - 11:18 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2022-11 v7.0 PL
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.				



6410653040

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych - c.d.

Troka Paweł

PESEL: 91021407790
Data urodzenia: 14-02-1991
Adres: nie podano
Ident. pacjenta: 193744
Płeć: mężczyzna
Ident. dokumentu zlecenia: AS00018392
Nr/data w księdze prac. diagn.: 5508 / 20-05-2026

Zleceniodawca: ALAB Sport, Lab. Gdynia
Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca
Lekarz zlecający: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza
Data i godz. rejestracji zlecenia: 07-07-2026 07:09
Data wykonania badania: 07-07-2026

Immunochemia - c.d.

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:02 (Zuzanna Stelmaszuk), data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:32				
Witamina D-25(OH)	46,0 ng/ml	< 10 ciężki niedobór 10-20 znaczny niedobór >20-30 stężenie suboptymalne >30-50 stężenie optymalne >50-100 stężenie wysokie >100 stężenie potencjalnie toksyczne	c3 - 12:44 07-07-2026	Instrukcja DiaSorin, wyd. 2024-03 v3.0 PL
Ocena stanu zapotrzebowania organizmu w witaminę D dla wszystkich grup wiekowych wg Rekomendacji: zasady suplementacji i leczenia witaminą D (2018)				
metoda chemiluminescencji bezpośredniej, analizator LIAISON XL, firma DiaSorin				
Witamina B12 (O83)	↑ 859 pg/ml	197 — 771	d3 - 11:18 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-01 v9.0 PL
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.				
Kwas foliowy (M41)	21,1 ng/ml	3,9 — 26,8	d3 - 12:05 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2023-10 v1.0 PL
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.				
Ferrytyna (L05)	42 ng/ml	30 — 400	d3 - 11:18 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2023-12 v7.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA).				
Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-S) (K27)	92,9 µg/dl	88,9 — 427,0	c3 - 13:55 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-02 v6.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA).				
NT-proBNP (N-terminalny propept. natriuret. t.B)	14,6 pg/ml	Punkt odcięcia: <125 Punkt odcięcia dla zastoinowej niewydolności serca z ostrą dusznością wg. badania ICON: < 50 lat >450 50-75 lat >900 > 75 lat >1800	c3 - 13:59 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2023-12 v4.0 PL
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.				
Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-1 (Somatomedyna C) (O32)	158 ng/ml	61 — 271	c3 - 12:44 07-07-2026	Instrukcja DiaSorin, wyd. 2023-06 v20.0 PL



6410653040

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych - c.d.

Troka Paweł

PESEL: 91021407790
Data urodzenia: 14-02-1991
Adres: nie podano
Ident. pacjenta: 193744
Płeć: mężczyzna

Zleceniodawca: ALAB Sport, Lab. Gdynia
Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca
Lekarz zlecający: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza
Data i godz. rejestracji zlecenia: 07-07-2026 07:09
Data wykonania badania: 07-07-2026

Ident. dokumentu zlecenia: AS00018392
Nr/data w księdze prac. diagn.: 5508 / 20-05-2026

Wyniki w późniejszym terminie

Homocysteina met. HPLC	Czas oczekiwania na wynik do 6 dni roboczych
Interleukina 6 - cytokina prozapalna (M05)	Czas oczekiwania na wynik do 2 dni roboczych
Kalprotektyna krążąca	Czas oczekiwania na wynik do 6 dni roboczych
Mioglobina	Czas oczekiwania na wynik do 4 dni roboczych
Selen (O31)	Czas oczekiwania na wynik do 13 dni roboczych
Witamina A (retinol) w surowicy (O81)	Czas oczekiwania na wynik do 8 dni roboczych
Witamina B1 (Tiamina)	Czas oczekiwania na wynik do 8 dni roboczych
Witamina B6	Czas oczekiwania na wynik do 8 dni roboczych
Witamina C	Czas oczekiwania na wynik do 8 dni roboczych
Witamina E (tokoferol) w surowicy	Czas oczekiwania na wynik do 8 dni roboczych
Cynk w surowicy (K15)	Czas oczekiwania na wynik do 13 dni roboczych

A – badane cechy i metody akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji; PB - procedura badawcza

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do próbek, której rodzaj, data i godzina pobrania, data i godzina przyjęcia do badań są identyfikowane w niniejszym sprawozdaniu.

Identyfikacja pacjenta odbywa się na podstawie pierwszych 9 cyfr kodu kreskowego (licząc od lewej). 10 cyfra jest cyfrą przeznaczoną dla laboratorium. Więcej informacji na stronie: <https://sklep.alablaboratoria.pl/922-przygotowanie-do-badania>.

Wykonali

a - Dudek Magdalena
b - Scheffs Alicja
c - Kopeć Sebastian
d - Smolarska Wiktoria

Zatwierdzili

1 - mgr Magdalena Dudek
2 - mgr Alicja Scheffs
3 - mgr Sebastian Kopeć
4 - mgr Karolina Szczerbiak

Niniejszy wydruk jest informacją o sprawozdaniu z badania laboratoryjnego. Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Autoryzował diagnosta laboratoryjny Szczerbiak Karolina nr PWZDL 20179